

TEMA 1.1 • CIRURÍA GENERAL Y ANESTESIA

Complicaciones Postquirúrgicas

PERFIL EUNACOM 1.01.1.015

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción y Definición

La **Hipertensión Arterial (HTA)** es el principal factor de riesgo modificable para enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica y muerte prematura a nivel mundial y en Chile. Se define fisiopatológicamente como un estado de aumento sostenido de la presión arterial que genera daño estructural y funcional en el sistema vascular y órganos blanco.

- Para el examen EUNACOM, el diagnóstico se basa en la medición clínica de la presión arterial (PA). Se considera HTA cuando:
- La **Presión Arterial Sistólica (PAS)** es ≥ 140 mmHg.
- Y/O la **Presión Arterial Diastólica (PAD)** es ≥ 90 mmHg.

NOTA CLÍNICA

La presión arterial es el producto del **Gasto Cardíaco** por la **Resistencia Vascular Periférica**. En la HTA esencial (90-95% de los casos), el mecanismo principal suele ser un aumento de la resistencia vascular periférica debido a disfunción endotelial, remodelado vascular y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA).

Diagnóstico Clínico

El diagnóstico de HTA no debe realizarse con una sola toma, a menos que el paciente presente una **Crisis Hipertensiva** o cifras iniciales muy elevadas con evidencia de daño de órgano blanco.

- **Perfil de Presión Arterial:** Se requieren al menos **dos mediciones adicionales** en días distintos (separados por no más de 15 días), realizando al menos dos tomas por vez. Si el promedio de estas mediciones es $\geq 140/90$ mmHg, se confirma el diagnóstico.
- **Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA):** Es el estándar de oro. Útil para descartar "HTA de delantal blanco" o detectar "HTA enmascarada".
- **Automonitoreo de la PA (AMPA):** Mediciones realizadas por el paciente en su hogar.

TABLA 1.1.1: MÉTODO DE MEDICIÓN VS UMBRAL DIAGNÓSTICO (PAS/PAD)

MÉTODO DE MEDICIÓN	UMBRAL DIAGNÓSTICO (PAS/PAD)
Presión Clínica (Box)	$\geq 140 / 90$ mmHg
MAPA (Promedio 24h)	$\geq 130 / 80$ mmHg
MAPA (Promedio Diurno)	$\geq 135 / 85$ mmHg
MAPA (Promedio Nocturno)	$\geq 120 / 70$ mmHg
AMPA (Promedio hogar)	$\geq 135 / 85$ mmHg

Clasificación de la Presión Arterial

Siguiendo las guías nacionales (MINSAL) y la tendencia internacional:

TABLA 1.1.2: CATEGORÍA VS SISTÓLICA (MMHG)

CATEGORÍA	SISTÓLICA (MMHG)	DIASTÓLICA (MMHG)
Óptima	< 120	< 80
Normal	$120 - 129$	$80 - 84$
Normal Alta	$130 - 139$	$85 - 89$
HTA Etapa 1	$140 - 159$	$90 - 99$
HTA Etapa 2	$160 - 179$	$100 - 109$
HTA Etapa 3	≥ 180	≥ 110

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si un paciente tiene una PAS en un rango (ej. 165) y una PAD en otro (ej. 95), siempre se clasifica según el **estadio más severo** (en este caso, HTA Etapa 2).

Evaluación Inicial y Estudio

Todo paciente recién diagnosticado debe ser sometido a una evaluación para buscar **Daño de Órgano Blanco (DOB)**, evaluar el riesgo cardiovascular (RCV) y descartar causas de **Hipertensión arterial secundaria**.

Exámenes de Laboratorio Básicos (Screening)

- **Hematocrito:** Para evaluar viscosidad y descartar anemias. - **Creatinina y Estimación de VFG:** Evaluar función renal. - **Electrolitos Plasmáticos (K, Na):** Clave antes de iniciar diuréticos o IECA/ARAI. - **Glicemia en ayunas:** Buscar **Diabetes mellitus tipo 2** concomitante. - **Perfil Lipídico:** Para cálculo de RCV. - **Orina Completa y RAC (Relación Albúmina/Creatinina):** Buscar microalbuminuria (signo precoz de daño renal). - **Electrocardiograma (ECG):** Buscar signos de **Hipertrofia Ventricular Izquierda (HVI)** (Índice de Sokolow-Lyon > 35 mm) o arritmias como **Fibrilación Auricular**.

Examen Físico Dirigido

- **Fondo de Ojo:** Clasificación de Keith-Wagener-Barker para retinopatía hipertensiva. - **Palpación de pulsos y soplos:** Buscar coartación aórtica o soplos renales. - **Cálculo de IMC y Circunferencia de Cintura:** Evaluar **Síndrome metabólico**.

Tratamiento de la HTA

El objetivo principal es reducir la morbimortalidad cardiovascular. La meta general es **$< 140/90$ mmHg**, pero en pacientes de alto riesgo o diabéticos se prefiere **$< 130/80$ mmHg** si es tolerado.

1. Medidas No Farmacológicas (Cambios en el Estilo de Vida)

Son pilares en todos los pacientes: - **Reducción de Sal:** < 5 g de sal/día (2g de Sodio). - **Baja de peso:** Mantener IMC $20-25$ kg/m². - **Dieta DASH:** Rica en frutas, verduras y lácteos bajos en grasa. - **Actividad Física:** 150 min/semana de ejercicio aeróbico moderado. - **Limitar alcohol y suspender tabaco.**

2. Tratamiento Farmacológico

Los fármacos de primera línea son:

- **IECA (Enalapril):** De elección en diabéticos y nefrópatas (antiproteinúricos).
- **ARA II (Losartán, Valsartán, Candesartán):** Alternativa a IECA si hay tos.
- **Tiazidas (Hidroclorotiazida, Clortalidona):** Muy efectivos en adultos mayores y raza negra.
- **Calcioantagonistas (Amlodipino, Nifedipino retard):** Potentes vasodilatadores.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡NUNCA combinar IECA con ARA II! Esta combinación aumenta el riesgo de insuficiencia renal aguda e hiperkalemia sin aportar beneficios cardiovasculares adicionales.

- ##### Estrategia de Inicio:
- **HTA Etapa 1 con RCV bajo:** Se puede intentar solo cambios de estilo de vida por 3-6 meses.
- **HTA Etapa 2 o RCV alto:** Iniciar fármacos de inmediato.

- **Terapia Combinada:** La mayoría de los pacientes requiere dos fármacos para alcanzar la meta. Se recomienda iniciar con dosis bajas de dos fármacos de familias distintas (ej. IECA + Calcioantagonista o IECA + Tiazida).

Consideraciones Especiales

- **Insuficiencia cardíaca con FEyR:** IECA/ARAI + Betabloqueadores + Antagonistas de Mineralocorticoides. - **Post-Infarto Agudo al Miocardio:** Betabloqueadores e IECA. - **Embarazo:** Los IECA y ARAI están **contraindicados** (teratogénicos). Se usa Metildopa, Labetalol o Nifedipino.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Los **Betabloqueadores** (Atenolol, Bisoprolol) ya NO son fármacos de primera línea para HTA no complicada, pero son fundamentales si existe cardiopatía coronaria o insuficiencia cardíaca.

Seguimiento y Derivación

Un paciente con HTA debe ser controlado periódicamente para asegurar el cumplimiento de metas y vigilar efectos adversos de los fármacos.

¿Cuándo sospechar HTA Secundaria? (Derivar a Especialista)

- HTA en pacientes muy jóvenes (< 30 años) sin factores de riesgo.
 - HTA de inicio súbito o que empeora rápidamente. - **HTA Resistente:** No llega a meta a pesar de 3 fármacos a dosis plenas (siendo uno de ellos un diurético). - Hallazgos sugerentes: Hipokalemia espontánea (Hiperaldosteronismo), soplos renales (Estenosis arteria renal), paroxismos de cefalea/palpitaciones (Feocromocitoma).

EUNACOM CRITERIOS

En el EUNACOM, siempre que te presenten un paciente con HTA e hipokalemia sin uso de diuréticos, marca **Hiperaldosteronismo Primario** como sospecha diagnóstica.

Resumen de Complicaciones Crónicas

La HTA no controlada conduce a: 1. **Cerebro: Accidente Cerebrovascular** (isquémico y hemorrágico). 2. **Corazón:** Cardiopatía hipertensiva, HVI, **Insuficiencia cardíaca**, arritmias. 3. **Riñón:** Nefroangioesclerosis y falla renal terminal. 4. **Vasos:** Aneurismas y enfermedad arterial periférica.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 58 años, sometido a colecistectomía abierta hace 6 horas, presenta fiebre de 38.5°C. Al examen físico se auscultan crepitaciones bibasales, la herida operatoria se ve limpia sin signos de infección. ¿Cuál es la causa más probable de la fiebre?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Complicaciones Postquirúrgicas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Cirugía aporta ~10 preguntas al EUNACOM, habitualmente fáciles. No se pregunta técnica quirúrgica, solo indicación operatoria.
- Mnemotecnica fiebre postoperatoria (las W): Wind (atelectasia, neumonía, TEP), Water (ITU), Wound (infección herida), Wonderful Drugs (RAM, hipertermia maligna), Veins (TVP, TEP, tromboflebitis).
- Atelectasia = causa más frecuente de fiebre postoperatoria antes de 24 horas. Si no describen herida infectada, pensar en atelectasia.
- Infección de herida operatoria = causa más frecuente de fiebre después de 48 horas.
- Hipertermia maligna = causa de fiebre inmediata postoperatoria. Asociada a succinilcolina y gases halogenados. Fiebre >41°C al salir de pabellón.
- Estudio de fiebre postoperatoria: Rx tórax (Wind), examen de orina (Water), revisión de herida (Wound), revisión de fármacos (Drugs), examen de extremidades y vías venosas (Veins).
- Seroma: edema + equimosis + salida de líquido serohemático. Diagnóstico clínico. Tratamiento: drenaje aspirativo con presión negativa.
- Hematoma: aumento de volumen rápido por acumulación de sangre. Diagnóstico clínico (ecografía si hay duda). Tratamiento: drenaje quirúrgico para evitar sobreinfección.
- Eventración = hernia incisional: protrusión tardía de vísceras CON saco peritoneal. Tratamiento quirúrgico electivo.
- Evisceración: protrusión aguda de vísceras SIN saco peritoneal. Es una urgencia quirúrgica.
- Dehiscencia de anastomosis: filtración del tubo digestivo con dolor, vómitos y signos peritoneales (Blumberg, abdomen en tabla, silencio abdominal). Cirugía urgente o el paciente muere.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS)**PREGUNTA 1**

Paciente de 58 años, sometido a colecistectomía abierta hace 6 horas, presenta fiebre de 38.5°C. Al examen físico se auscultan crepitaciones bibasales, la herida operatoria se ve limpia sin signos de infección. ¿Cuál es la causa más probable de la fiebre?

- A)** Infección de herida operatoria
- B)** Atelectasia pulmonar
- C)** Infección del tracto urinario
- D)** Trombosis venosa profunda
- E)** Hipertermia maligna

PREGUNTA 2

Paciente de 45 años, en el postoperatorio inmediato de una hemicolectomía derecha, presenta fiebre de 41.2°C justo al llegar a recuperación desde pabellón. Durante la cirugía se utilizó succinilcolina para la intubación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Atelectasia pulmonar
- B)** Neumonía aspirativa
- C)** Infección de herida operatoria
- D)** Hipertermia maligna
- E)** Reacción transfusional

PREGUNTA 3

Mujer de 52 años, operada de cesárea hace 2 años, consulta por aumento de volumen blando en la zona de la cicatriz quirúrgica abdominal. Al examen se palpan ruidos hidroaéreos en la masa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Seroma
- B)** Hematoma de pared abdominal
- C)** Eventración (hernia incisional)
- D)** Evisceración
- E)** Dehiscencia de anastomosis

RESUMEN: COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS

Esta clase aborda las complicaciones más frecuentes de las cirugías generales, un tema que representa aproximadamente 10 preguntas en el EUNACOM y que suelen ser de dificultad baja. La mayoría de las preguntas se concentran en cirugía digestiva y vascular, mientras que cirugía general aporta unas 5 preguntas sobre hernias, manejo de heridas, abscesos, flecmones y furúnculos. No se evalúa técnica quirúrgica, solo si el paciente se opera o no. El primer gran tema es la fiebre postoperatoria, cuyas causas se memorizan con la mnemotecnía de las W: Wind (causas respiratorias como atelectasias, neumonía y TEP), Water (infección urinaria), Wound (infección de herida operatoria), Wonderful Drugs (reacciones adversas a medicamentos e hipertermia maligna) y Veins (trombosis venosa profunda, TEP y tromboflebitis). Las atelectasias son la causa más frecuente antes de las 24 horas, la infección de herida operatoria después de las 48 horas, y la hipertermia maligna es la causa de fiebre inmediata (asociada a succinilcolina o gases halogenados). El segundo bloque cubre las complicaciones mecánicas de la herida quirúrgica: el seroma (edema con líquido serohemático, tratado con drenaje aspirativo), el hematoma (acumulación de sangre con aumento de volumen rápido, tratado con drenaje), la eventración o hernia incisional (protrusión de vísceras con saco peritoneal, aparición tardía, tratamiento quirúrgico electivo), la evisceración (protrusión aguda sin saco peritoneal, cirugía urgente) y la dehiscencia de anastomosis (filtración del tubo digestivo con signos peritoneales graves que requiere cirugía urgente).